

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGAMBILAN DARAH PERIFER PADA BAYI		
	No.Dokumen 922.14/I-SPO/NEO/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 September 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Tindakan pengambilan sampel darah pembuluh darah perifer (bisa melalui tusukan tumit/ <i>heel prick</i> untuk kapiler atau vena superfisial) pada bayi baru lahir maupun bayi usia < 1 tahun untuk pemeriksaan laboratorium		
Tujuan	1. Mendapatkan sampel darah yang valid dan akurat untuk pemeriksaan laboratorium 2. Meminimalkan trauma, rasa nyeri, dan risiko komplikasi (misal: infeksi, hematoma) pada bayi 3. Memastikan keselamatan pasien (<i>patient safety</i>) selama prosedur		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 813.1/I-PDM/DIR/IX/2025 Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien		
Prosedur	A. Persiapan alat 1. Sarung tangan steril/bersih (sesuai kebijakan unit). 2. <i>Lancing device</i> otomatis (kapiler) khusus bayi (kedalaman tusukan tidak boleh melebihi 2.0 mm). 3. Kapas alkohol 70% atau <i>alcohol swab</i> . 4. Kasa steril. 5. Tabung mikro (mikrotainer) sesuai jenis pemeriksaan. 6. Plester khusus bayi. 7. Penghangat tumit (<i>heel warmer</i>) atau kain hangat jika diperlukan. B. Langkah- langkah 1. Lakukan verifikasi identitas bayi melalui gelang identitas (Nama dan tanggal lahir) 2. Jelaskan prosedur kepada orang tua untuk mendapatkan persetujuan 3. Cuci tangan sesuai prosedur 6 langkah 4. Menentukan Lokasi Tusukan 5. Pilih area lateral atau medial dari telapak tumit (sisi pinggir). Penting: Hindari area tengah tumit dan bagian belakang tulang tumit (<i>calcaneus</i>) untuk mencegah risiko <i>osteomyelitis</i> 6. Posisikan bayi: Pastikan kaki bayi dalam posisi lebih rendah dari jantung untuk memperlancar aliran darah 7. Penghangatan: Jika tumit terasa dingin, kompres dengan air hangat (maksimal 42°C) selama 3–5 menit untuk meningkatkan vasodilatasi		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGAMBILAN DARAH PERIFER PADA BAYI		
	No.Dokumen 922.14/I-SPO/NEO/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	8. Desinfeksi: Bersihkan lokasi tusukan dengan <i>alcohol swab</i> dengan gerakan sirkular. Biarkan kering udara sepenuhnya agar tidak terjadi hemolisis dan rasa perih 9. Tusukan: Pegang tumit dengan mantap namun lembut. Tekan <i>lancet</i> pada posisi tegak lurus di area lateral/medial 10. Hapus tetesan pertama: Gunakan kasa steril untuk menghapus tetes darah pertama karena biasanya mengandung cairan jaringan yang dapat mengencerkan specimen 11. Pengambilan sampel: Berikan tekanan lembut dan intermiten (jangan memeras atau "memerah" terlalu kuat karena dapat merusak sel darah) 12. Penampungan: Arahkan darah ke dalam tabung mikro sesuai volume yang dibutuhkan 13. Setelah selesai, tekan area tusukan dengan kasa steril hingga perdarahan berhenti 14. Pasang plester jika diperlukan 15. Rapikan alat dan cuci tangan 16. Catat waktu pengambilan, lokasi penusukan, dan respon bayi 17. Pastikan label pada tabung spesimen sudah benar dan segera kirim ke laboratorium		
Unit Terkait	Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Perinatologi		